

Deck hiện tại đang trả lời "**công nghệ này là gì**". Cần chuyển sang trả lời "**AI hỗ trợ được quyết định lâm sàng nào, và rủi ro đã xử lý tới đâu**" — minh chứng thuyết phục hơn để Vinmec nhìn thấy hiệu quả.

Thay đổi cốt lõi, hướng kể câu chuyện tiềm năng

Hiện tại	Gợi ý
Mở bằng định nghĩa MFCV	Mở bằng khoảng trống lâm sàng — cái Motion Lab đang chưa nhìn thấy
Rủi ro Noraxon để ngỏ ở slide cuối	Đưa lên sớm, nói trực diện, kèm Plan B
Lợi ích liệt kê chung	Tách rõ <i>đã có bằng chứng</i> vs <i>giả thuyết cần thí điểm</i>
Demo ở cuối	Demo đan xen trong nội dung để tạo ấn tượng giải pháp

Đề xuất 3 slide mở đầu

S1 — Khoảng trống. Motion Lab đã đo được sức cơ (Compass 600), động học (VICON), kích hoạt cơ (Noraxon). Nhưng khi BS quyết định "*hôm nay có nên tăng tải cho BN này không?*" — đang thiếu là chỉ dấu sinh lý báo mỗi **trước khi** sức cơ tụt rõ. Đặt câu hỏi, đưa ra vấn đề

S2 — Ca minh họa (thật hoặc dự tính). Một BN cụ thể, before/after. VD: tuần 6 sau tái tạo ACL, sức cơ đạt 85% chân lành → phác đồ hiện tại cho tăng tải. Với MFCV: mỗi sớmm khu trú ở vastus medialis ở mức tải thấp hơn dự kiến → giữ tải. *Đây là hình dạng của giá trị.* Nếu có ca thật thì tốt; nếu chưa, dùng ca giả định và ghi rõ là minh họa/giả thuyết cần thí điểm kiểm chứng.

S3 — Phạm vi & giới hạn. Giữ gần như nguyên slide 2 hiện tại — phần này đang làm tốt.

Sửa chi tiết

Slide 2 — Phạm vi & giới hạn. Điểm mạnh nhất của pitch. Giữ nguyên.

Slide 3 — Khoa đối tác. OK. Có thể cân nhắc thêm một dòng: khoa nào sẽ là người *dùng thật* hàng ngày — BS hay KTV?

Slide 4 — Bối cảnh & khác biệt. Có thể gọn lại thành bảng so sánh thuần túy.

Slide 5 — Lợi ích. Hai chỗ cần nghĩ lại:

- Có thể tách 2 cột: **đã có bằng chứng y khoa** (MFCV giảm theo mỗi — nền vững) vs **giả thuyết cần thí điểm**.
- $F1 = 95,12\%$ đang in to như bằng chứng lâm sàng. Cần nhắc ghi rõ điều kiện + thêm dòng *"chưa validate trên BN Vinmec — đây chính là mục tiêu thí điểm"*.

Slide 6 — Tích hợp phần cứng. Slide cần sửa nhất về mặt kỹ thuật. Đảm bảo các claim trong này chính xác; cái nào đang là ước lượng thì nói rõ là ước lượng.

Slide 7 — Hạ tầng vận hành (OH/eForm/EMR). Tốt, giữ nguyên.

Slide 8 — Quy trình 7 bước. Slide chưa trả lời: buổi đo mất bao nhiêu phút? Ai đọc và ký kết quả? Có làm nghẽn Motion Lab không (nguồn lực dùng chung)? Một dòng dưới sơ đồ để diễn tả.

Ngoài ra: **abstention gate (bước 3)** là điểm khác biệt an toàn mạnh nhất của cả đề xuất nhưng đang nằm trong một dòng chú thích cỡ nhỏ. Rất đáng nâng lên, cần thiết có thể demo .

Slide 9 — Bước tiếp theo. Gọi ý gộp thành "Thí điểm 1 trang":

Hạng mục	Đề xuất (số cần team điền lại)
Đối tượng	$N \approx 30$ BN sau tái tạo ACL, tuần 4–12
Cơ mục tiêu	Vastus medialis, vastus lateralis, hamstring
Thời gian	12 tuần thu thập + 4 tuần phân tích
Tần suất	1 buổi/tuần, lồng vào buổi PHCN sẵn có — 0 lượt hẹn Motion Lab phát sinh
Chi phí	Phần cứng (module array nếu cần) + nhân lực

Chèn 2 demo

Demo 1 — Mọi cơ trong buổi tập → đặt sau slide Lợi ích.

Demo 2 — Tiến độ hồi phục qua các buổi → đặt sau quy trình 7 bước (gắn bước 7 Longitudinal).

Đây là một số đề xuất về slide triển khai. Team cần nhắc